

Hiperplasia endometrial y cáncer de endometrio

1. Introducción y relevancia clínica

La **hiperplasia endometrial** y el **cáncer de endometrio** forman un **continuo fisiopatológico** que va desde una **estimulación estrogénica prolongada sin oposición progestacional**, hacia una **proliferación neoplásica maligna del endometrio**.

El **cáncer de endometrio** es el **más frecuente del tracto genital femenino** en países desarrollados y el **segundo más común en Chile**, después del cáncer cervicouterino.

Su detección temprana es posible porque el **síntoma cardinal —metrorragia posmenopáusica— ocurre precozmente**, permitiendo diagnóstico oportuno en la mayoría de los casos.

- En EUNACOM es frecuente que se plantee una mujer posmenopáusica con metrorragia y engrosamiento endometrial, pidiendo la conducta diagnóstica inicial o el tratamiento según resultado histológico.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Fisiopatología de la hiperplasia endometrial

El endometrio responde cíclicamente al estímulo hormonal:

- **Estrógenos** → proliferación glandular.
- **Progesterona** → maduración secretora y control del crecimiento.

Cuando existe **exceso estrogénico sin oposición progestacional**, se produce una **estimulación continua del endometrio**, originando **hiperplasia**, que puede progresar a **adenocarcinoma**.

b. Factores de riesgo

Exceso estrogénico endógeno

Exceso estrogénico exógeno

Anovulación crónica (SOP)	Terapia estrogénica sin progestágeno
Obesidad (aromatización periférica)	Tamoxifeno
Menarquia precoz, menopausia tardía	ACO mal balanceado
Nuliparidad	Estrógenos sin oposición

☐ La **obesidad** es el factor de riesgo más relevante en Chile.

c. Tipos de cáncer endometrial (clasificación de Bokhman)

Tipo	Características	Ejemplo
Tipo I (endometriode)	Asociado a hiperestrogenismo, sobrepeso, edad media, buen pronóstico	Adenocarcinoma endometriode
Tipo II (no endometriode)	No dependiente de estrógenos, edad avanzada, peor pronóstico	Seroso, de células claras

80–85% de los casos corresponden al **tipo I**, originado en una **hiperplasia atípica**.

3. Clínica

a. Síntoma principal

Metrorragia posmenopáusica (hasta 90% de los casos).

En mujeres premenopáusicas: **menorragia, metrorragia o sangrado intermenstrual**.

b. Otros síntomas

- Flujo serohemático persistente.
- Dolor pélvico o cólico.
- Aumento de volumen uterino (en etapas avanzadas).

□ Toda **metrorragia posmenopáusica** debe considerarse **cáncer de endometrio** hasta demostrar lo contrario.

4. Diagnóstico diferencial

Causa	Característica
Atrofia endometrial	Causa más frecuente de sangrado posmenopáusico
Pólipo endometrial	Sangrado leve, intermitente
Mioma submucoso	Metrorragia abundante, útero aumentado
Cáncer de cuello uterino	Flujo fétido, sangrado postcoital
Terapia hormonal	Sangrado asociado a uso de estrógenos

5. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a.

Ecografía transvaginal

- Examen de elección inicial ante metrorragia posmenopáusica.

- Se mide el **grosor endometrial** (en línea media).

Paciente	Valor normal	Conducta
Posmenopáusica sin TH	<4 mm	Observación
Posmenopáusica con TH	<5 mm	Observación
≥4–5 mm	Hacer biopsia endometrial	

☐ Si hay sangrado persistente con endometrio <4 mm, aún debe realizarse biopsia, ya que algunos carcinomas son focales.

b.

Biopsia endometrial (gold standard)

- Realizada con cánula de **Pipelle** o mediante **histeroscopia con biopsia dirigida**.
- Permite diferenciar:
 - Endometrio proliferativo/secretor.
 - Hiperplasia simple o compleja.
 - Hiperplasia con atipia.
 - Adenocarcinoma.

c.

Histeroscopia

- Indicación: sangrado persistente o lesiones focales.
- Permite visualizar pólipos y dirigir biopsia.

d.

Marcadores tumorales

- **CA-125** puede elevarse, especialmente en enfermedad avanzada (no diagnóstico).

6. Clasificación histológica de la hiperplasia endometrial (OMS 2014)

Tipo	Riesgo de progresión a cáncer
Hiperplasia sin atipia	<2%
Hiperplasia con atipia (neoplasia intraepitelial endometrial)	25–40%

☐ La **hiperplasia con atipia** se considera una **lesión precancerosa**, y su manejo depende del deseo reproductivo.

7. Tratamiento de la hiperplasia endometrial

a.

Sin atipia

- Controlar factores de riesgo (obesidad, anovulación).
- **Tratamiento médico:**
 - **Progestágenos orales:** acetato de medroxiprogesterona, acetato de megesterol.
 - **DIU liberador de levonorgestrel (Mirena®):** muy eficaz.
- **Seguimiento:** biopsia endometrial cada 6–12 meses.

b.

Con atipia

Deseo de fertilidad	Conducta
Sí	Progestinas altas dosis o DIU-LNG + biopsia cada 3–6 meses
No	Histerectomía total (tratamiento definitivo)

8. Cáncer de endometrio

a.

Diagnóstico

Confirmado histológicamente mediante biopsia endometrial o histerectomía diagnóstica.

b.

Clasificación FIGO (2021)

Etapas	Extensión
I	Limitado al cuerpo uterino
II	Compromete cérvix
III	Extensión local o ganglionar

IV Invasión vesical, intestinal o metástasis

C.

Factores pronósticos

- Grado histológico (G1–G3).
- Invasión miometrial (>50%).
- Compromiso linfático.

9. Tratamiento del cáncer de endometrio (según etapa)

Etapa	Tratamiento principal	Comentario
I–II	Histerectomía total + salpingooforectomía bilateral + linfadenectomía selectiva	Puede requerir radioterapia adyuvante
III–IV	Cirugía citorreductora + radioterapia ± quimioterapia	Carboplatino + paclitaxel
No operables	Progestinas altas dosis o radioterapia paliativa	En pacientes frágiles o metastásicas

☐ En mujeres jóvenes con enfermedad inicial y deseo de fertilidad, se puede intentar manejo médico con **progestinas altas dosis + seguimiento estricto**.

10. Seguimiento post-tratamiento

- **Examen pélvico** cada 3–6 meses los primeros 2 años, luego anual.
- Control de síntomas (sangrado, dolor pélvico).

- **Ecografía transvaginal o TAC** si sospecha de recidiva.
 - Control metabólico (peso, glicemia, HTA).
-

11. Complicaciones

Tipo	Descripción
Hematológica	Anemia por metrorragia crónica
Metabólica	Riesgo cardiovascular por síndrome metabólico
Reproductiva	Infertilidad en mujeres jóvenes
Oncológica	Recidiva local o metástasis en estadios avanzados

12. Prevención

- Control del peso y la obesidad.
 - Uso de **progestágenos** en mujeres con anovulación o THS con estrógenos.
 - **ACO combinados** reducen riesgo al estabilizar endometrio.
 - Tamizaje no se recomienda de rutina, salvo en síndrome de Lynch.
-

13. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Toda metrorragia posmenopáusica = descartar cáncer de endometrio.**
2. **Ecografía transvaginal** es el primer examen: grosor ≥ 4 mm = biopsia.
3. **Hiperplasia con atipia** → riesgo de cáncer (manejar con histerectomía).
4. **Cáncer endometrioide tipo I** = dependiente de estrógenos, mejor pronóstico.
5. **Tratamiento estándar:** histerectomía total + anexectomía bilateral.
6. **Progestinas o DIU-LNG** = opción en hiperplasia sin atipia o deseo gestacional.
7. **Obesidad y anovulación crónica** son los principales factores de riesgo.



Errores comunes

- No investigar metrorragia posmenopáusica.
- Indicar terapia estrogénica sin progestágeno en mujeres con útero.
- No realizar biopsia con endometrio >4 mm.
- Confundir pólipo endometrial con hiperplasia difusa.
- No considerar manejo conservador en jóvenes con deseo reproductivo.

14. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Hiperplasia endometrial:** proliferación benigna por exceso estrogénico.
2. **Cáncer de endometrio:** evolución maligna de una hiperplasia atípica.
3. Síntoma cardinal: **metrorragia posmenopáusica.**
4. **Ecografía transvaginal y biopsia endometrial** son diagnósticas.
5. **Progestinas o DIU-LNG** para hiperplasia sin atipia.

6. **Histerectomía total** es el tratamiento definitivo.
7. **Obesidad, anovulación y TH sin progestágeno** son los principales factores de riesgo.